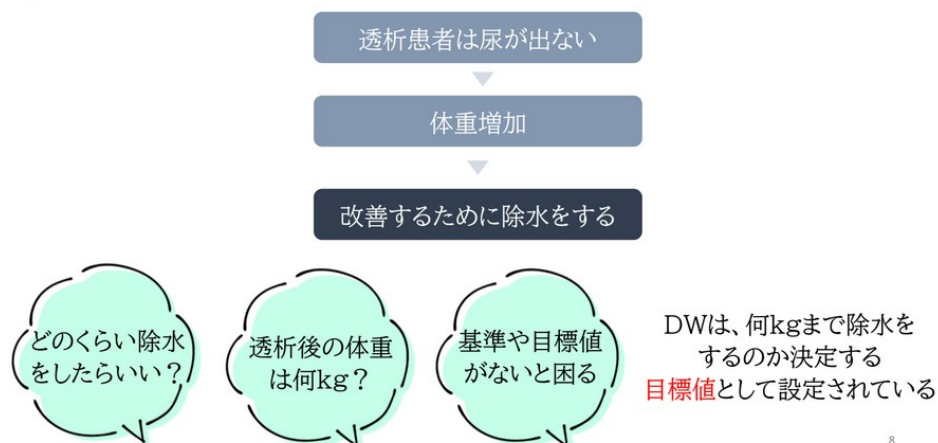


<DW（ドライウェイト）>

DW とは透析治療のために使用される言葉=透析後の目標体重のこと

なぜDWが必要？



※参考 DW の定義

「体液量が適正で、透析中に過度の血圧低下を生ずることなく、かつ長期的にも心血管系への負担が少ない体重」

透析間の体重増加の目安

中1日→DWの3% 中2日→DWの5~6% に抑える。

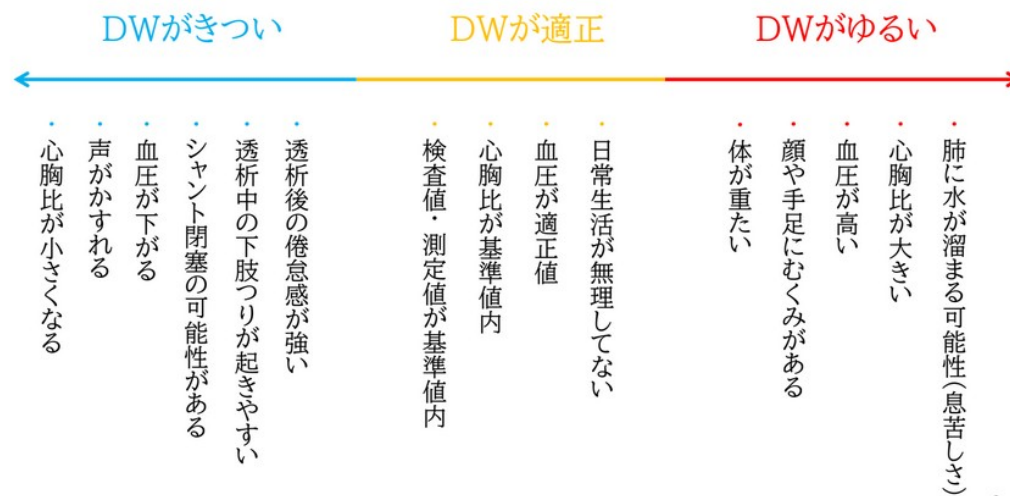
例：DW50.0kgの患者であれば、中1日で1.5kg 中2日で2.5~3.0kg

透析時の最大の除水速度の目安

$DW \times 15 \rightarrow \sim \text{ml/hr}$

例：DW50.0kg の患者であれば、750ml (0.75 ℓ) /hr

DWがきついと、ゆるいとうなる？



DW の決め方

DWは1つの項目で決まるものではなく、いくつかの項目から総合的に判断

みたきで主に使われているものを紹介

①浮腫

透析前 すねや足背部を押して、皮膚の沈みが強く戻りが遅かったら浮腫が強い。

浮腫が強い場合は、DW を下げる？

②血圧

血圧が常に高い→DW を下げる？ 血圧が常に低い→DW を上げる？

生命予後が最も良いのは、透析後の収縮期血圧が 120~160mmHg

血圧は患者の状態、透析前後の体液量による影響、季節的な影響、降圧剤の内服の有無など

様々で患者によって違う。

家庭血圧も毎透析ごとに確認することが重要！！

③心胸郭比（CTR）

胸郭の横幅に対し、心臓の横幅がどれだけあるかという比率のこと。

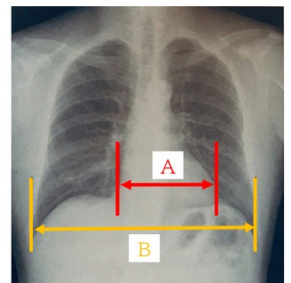
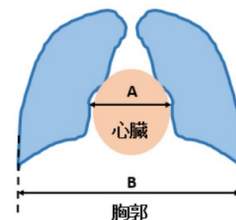
これによって心臓が大きくなっているか(水が溜まっているかどうか)がわかる。

CTR の基準値（透析後）

男性 50%以下 女性 55%以下

みたきでは透析前の測定のためこれに当てはまらない。

CTR計算方法



$$A(\text{心臓の幅}) \div B(\text{胸郭の幅}) \times 100(\%)$$

透析前の CTR 測定→溢水ではないかの判断（1kg で 1.5%）

透析後の CTR 測定→DW が合っているかどうかの判断

④ HANP（ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド）

基準値 25~100(pg/dL) 透析後に採血

心房圧による心房筋の伸展によって刺激されて出るホルモン

hANPは体液量の増加によって分泌される

体液量が多くなると数値が高くなる

hANP100以上

体液量が多い

DWを下げるか検討

hANP25以下

体液量が少ない

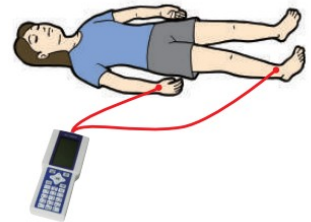
DWを上げるか検討



心房細動や弁膜症がある場合は増加する。
これらが無いことを確認して参考にするのが望ましい。

⑤ MLT=体組成計

細胞外液比、脂肪量などを測定する方法（測定記録の見方はMEまで）



細胞外液比とは

細胞外液比=細胞外水分量÷体水分量×100 → 一般的な基準値 35～40%

つまり体全体の水分量に対して細胞外水分（≡血管内水分）がどれだけあるかということ。

前より細胞外液比が増えた→血管内水分が増えた→DWを下げる？

減った→血管内水分が減った→DWを上げる？

脂肪量 毎月記録することでふとったかやせたかを確認しDWの増減に利用

ふとった→DWを上げる？ やせた→DWを下げる？

⑥ BV（ブラッドボリューム）計

透析棟のすべてのコンソールで BV を確認することが可能。確認方法は ME まで。

BV計とは透析中の除水によって起こる
血管内容量(ブラッドボリューム)の変化を経時的に評価する装置のこと

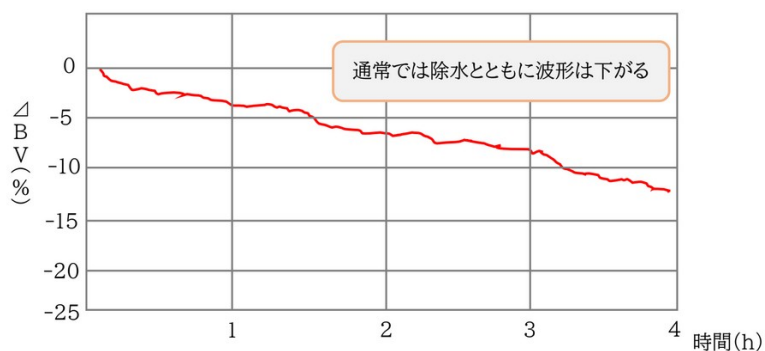
基準値: **-15%** 以内

-25%などの血管内容量の
少ない(濃縮率が大きい)状態

▶ 血圧が下がる傾向にある。
除水がきついかもしれないので
DWを上げるか検討する。

-5%などの濃縮が小さく
血管容量が保たれている状態

▶ 血圧は維持か上昇する傾向にある。
DWを下げるか検討する。



全ての DW を決める方法において患者ごとに基準値が違う場合が多い。

重要なことは前回や前月と比較し経時的变化を確認すること！！

内容に関する質問や意見等は ME 伊藤までお願いします。